

CAPÍTULO 14.7

Artrosis

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Artrosis** (u osteoartritis) es la patología articular más frecuente a nivel mundial. Se define como una enfermedad degenerativa del cartílago articular que puede ser altamente invalidante, especialmente en adultos mayores, comprometiendo significativamente su calidad de vida.

Clínica y Presentación Articular

A diferencia de la **Artritis Reumatoide**, la artrosis se caracteriza fundamentalmente por **artralgia** (dolor articular) sin signos inflamatorios sistémicos (sin artritis verdadera en etapas iniciales).

- **Características del dolor:** Es un dolor de tipo **mecánico**, es decir, que aumenta con el movimiento y la carga, y mejora con el reposo.
- **Evolución:** Si no se trata, el paciente tiende a la inmovilidad para evitar el dolor, lo que puede conducir a **anquilosis** o al síndrome de inmovilidad del adulto mayor.
- **Hallazgos en manos:**
 - **Nódulos de Bouchard:** Localizados en las articulaciones interfalángicas **proximales**.
 - **Nódulos de Heberden:** Localizados en las articulaciones interfalángicas **distales**.
 - Ambos son de consistencia dura (ósea) debido a que representan el crecimiento de **osteofitos**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para recordar los nódulos: **Bouchard** está **Cerca** (Proximal) y **Heberden** está **Lejos** (Distal) del tronco. O simplemente por orden alfabético de proximal a distal: **B** (Bouchard) antes que **H** (Heberden).

Nomenclatura según Localización

La artrosis recibe nombres específicos dependiendo de la articulación afectada:

TABLA 14.7.1: LOCALIZACIÓN VS NOMBRE ESPECÍFICO	
LOCALIZACIÓN	NOMBRE ESPECÍFICO
Base del pulgar (1° carpometacarpiana)	Risartrosis
Rodilla	Gonartrosis
Cadera	Coxartrosis
Columna vertebral	Espondilosis
Dedos (Interfalángicas)	Nódulos de Heberden y Bouchard

Diagnóstico

El diagnóstico de la artrosis es **clínico-radiológico**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta hallazgos radiográficos de desgaste pero **no tiene dolor**, no se diagnostica como artrosis, sino como "cambios degenerativos óseos". La clínica es soberana.

Hallazgos Radiográficos (Los 4 Pilares)

- Para confirmar el diagnóstico, buscamos cuatro signos clásicos en la radiografía:
- **Disminución del espacio articular:** Refleja la pérdida del cartílago (que es radiotransparente).
 - **Osteofitos:** Crecimiento óseo en los márgenes articulares como reacción al daño.

- **Esclerosis subcondral:** El hueso bajo el cartílago se vuelve más denso y blanco (radiopaco) por el aumento de carga.
- **Quistes (Geodas) subcondrales:** Zonas radiolúcidas (oscuras) dentro de la zona de esclerosis.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología se basa en la pérdida progresiva del cartílago hialino. Al desaparecer este "amortiguador", el hueso subcondral sufre mayor estrés mecánico, respondiendo con esclerosis y la formación de osteofitos para intentar aumentar la superficie de carga.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento se basa en dos pilares: **Analgésia** y **Ejercicios de fortalecimiento muscular** (especialmente el fortalecimiento de cuádriceps en gonartrosis y coxartrosis).

Escalera Farmacológica: Evidencia Actual vs. MINSAL

Existe una discrepancia entre la evidencia internacional reciente y las guías nacionales chilenas (MINSAL) que es importante conocer para el examen:

TABLA 14.7.2: NIVEL VS EVIDENCIA INTERNACIONAL ACTUAL		
NIVEL	EVIDENCIA INTERNACIONAL ACTUAL	GUÍA MINSAL (CHILE)
1° Línea	AINEs (Ibuprofeno, Celecoxib)	Paracetamol (1g c/8h)
2° Línea	Corticoides Intraarticulares	AINEs
3° Línea	Cirugía de reemplazo	Tramadol
Última Línea	-	Cirugía (Prótesis)

Consideraciones sobre los fármacos:

- **AINEs:** Son la base del tratamiento actual. Se pueden usar COX-1 (Ibuprofeno, Naproxeno) o COX-2 (Celecoxib). - **Corticoides Intraarticulares:** Útiles para crisis de dolor, pero su efecto es limitado (dura pocos meses). - **Paracetamol:** Aunque es seguro, la evidencia actual sugiere que suele ser insuficiente para el manejo del dolor artrósico moderado-severo. - **Tramadol:** Su uso es controvertido debido al riesgo de dependencia y caídas en el adulto mayor, aunque sigue siendo una opción en dolor refractario.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes con **falla renal (Insuficiencia Renal)** o antecedentes de **úlcera péptica**, el uso de AINEs está contraindicado o debe ser extremadamente cauteloso (preferir COX-2 en caso de riesgo gástrico, pero evitar ambos en falla renal).

Lo que NO se debe recomendar

Es fundamental no prescribir tratamientos que han demostrado **nula eficacia** y que representan un gasto innecesario para el paciente:

- **Glucosamina.**
- **Condroitín sulfato.**
- **Ácido hialurónico** (vía oral o intraarticular).
- **Plasma rico en plaquetas (PRP).**

EUNACOM CRITERIOS

El MINSAL y la evidencia internacional coinciden en que el condroitín sulfato y la glucosamina **no sirven** para modificar la historia natural de la enfermedad ni para el manejo del dolor de manera significativa.

Tratamiento Quirúrgico

La cirugía de reemplazo articular (prótesis de cadera o rodilla) se reserva para pacientes con: 1. Dolor intratable médicamente. 2. Limitación funcional severa que impide las actividades de la vida diaria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 65 años con dolor de rodillas que aumenta al caminar, sin signos inflamatorios. Radiografía muestra disminución del espacio articular y osteofitos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea según la evidencia actual?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artrosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La artrosis es la patología articular más frecuente: dolor sin artritis que aumenta con el movimiento
- Nódulos de Heberden (IFD) y Bouchard (IFP) son osteofitos de consistencia ósea
- Articulaciones más afectadas: IFD, IFP, rizartrosis, gonartrosis, coxartrosis, espondilosis
- Diagnóstico: radiografía (disminución espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral) + clínica
- Tratamiento primera línea: AINEs (no paracetamol según evidencia actual)
- Segunda línea: corticoides intraarticulares; última línea: cirugía de reemplazo articular
- No sirven: condroitín sulfato, glucosamina, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTROSIS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 65 años con dolor de rodillas que aumenta al caminar, sin signos inflamatorios. Radiografía muestra disminución del espacio articular y osteofitos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea según la evidencia actual?

- A)** Paracetamol 1g cada 8 horas
- B)** AINEs (ej. ibuprofeno o celecoxib)
- C)** Tramadol
- D)** Condroitín sulfato + glucosamina
- E)** Corticoides intraarticulares

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes hallazgos radiográficos NO es característico de la artrosis?

- A)** Disminución del espacio articular
- B)** Osteofitos
- C)** Erosiones en sacabocado
- D)** Esclerosis subcondral
- E)** Quistes subcondrales

PREGUNTA 3

Los nódulos de Heberden se ubican en las articulaciones:

- A)** Metacarpofalángicas
- B)** Interfalángicas proximales
- C)** Interfalángicas distales
- D)** Carpometacarpianas
- E)** Muñecas

RESUMEN: ARTROSIS

La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Se presenta con dolor articular sin artritis (artralgia), que aumenta con los movimientos y lleva a inmovilidad progresiva. En las manos se ven nódulos de Bouchard (IFP) y Heberden (IFD), ambos osteofitos de consistencia ósea. Las articulaciones más afectadas son: IFD e IFP (manos), primera carpometacarpiana (rizartrosis), rodillas (gonartrosis), caderas (coxartrosis) y columna (espondilosis). El diagnóstico es con radiografía más clínica: disminución del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y quistes subcondrales. El tratamiento de primera línea son los AINEs (no paracetamol según evidencia actual). De segunda línea corticoides intraarticulares (eficacia limitada en el tiempo). De última línea cirugía de reemplazo articular. No sirven: condroitín sulfato, glucosamina, ácido hialurónico ni plasma rico en plaquetas. El Minsal chileno aún recomienda paracetamol de primera línea.